

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente recurso.

Ab initio, estando o presente feito pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto no id. 27801333.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – REJEITADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL ESGOTA A JURISDIÇÃO, FAZENDO RESTAR PREJUDICADO RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AGT: 00326377420128120001 MS 0032637-74.2012.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE JULGAMENTO – Apelação julgada – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AGT: 10126345920208260309 Itatiba, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023)

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno e passo à análise do recurso do Agravo de Instrumento.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de cobertura, por operadora de plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol, prescrito para tratamento de epilepsia refratária em paciente infantil, diante da ausência de registro na ANVISA e da alegação de exclusão contratual por se tratar de medicamento de uso domiciliar.

Inicialmente, cumpre destacar que a Nota Técnica nº 274812 do NAT-Jus mencionada na decisão do Id. 26795134 se refere ao autismo, **não se aplicando ao caso concreto**, eis que no laudo juntado no Id. 139425587 o menor: "apresenta os seguintes diagnósticos neurológicos: antecedente de hipóxia perinatal (CID 10: P21), leucomalácia cerebral neonatal (CID 10: P91.2), paralisia cerebral (CID 10: G80.0), epilepsia (CID 10: G40.8), gastrostomia (CID 10: Z93.1) e atraso global no desenvolvimento (CID 10: F83)", já tendo feito "uso de fenobarbital, levetiracetam e lacosamida em doses efetivas; entretanto, ainda não houve controle das crises epiléticas. Por esse motivo, foi prescrito canabidiol Prati-Donaduzzi 200 mg/mL, na dosagem de 0,85 mL a cada 12 horas, totalizando 51 mL por mês, o que equivale a dois frascos".

Observe-se também, que na própria Nota técnica mencionada consta que o Conselho Federal de Medicina em 2022 autorizou a prescrição do canabidiol (CBD) como terapêutica médica, se indicadas para o tratamento de epilepsias na infância e adolescência refratárias às terapias convencionais na Síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut e no Complexo de Esclerose Tuberosa."

Deve-se então observar que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 990, firmou entendimento no sentido de que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos não registrados na ANVISA. Contudo, a própria Corte Superior admite a aplicação da técnica do *distinguishing* em casos excepcionais, nos quais a ausência de registro é suprida por autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA, especialmente quando demonstrada a eficácia do tratamento e a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes.

No caso em apreço, verifica-se que o medicamento prescrito possui autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA, conforme documentos acostados aos autos. Ademais, há prescrição médica específica indicando a necessidade do uso do canabidiol para o tratamento da epilepsia refratária do menor, diante da ineficácia de outras terapias convencionais.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a obrigatoriedade de cobertura, por planos de saúde, de medicamentos à base de canabidiol, mesmo em casos de uso domiciliar e ausência de registro na ANVISA, desde que haja prescrição médica e autorização excepcional de importação. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do STJ no AgInt no REsp 1.885.447/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022, que reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de medicamento importado sem registro na ANVISA, mas com autorização excepcional de importação.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, reforça a proteção do consumidor em situações como a presente.

No que tange à alegação de exclusão contratual por se tratar de medicamento de uso domiciliar, a jurisprudência consolidada entende que tal cláusula é abusiva quando o medicamento é essencial para o tratamento da doença coberta pelo plano de saúde e não há alternativa terapêutica eficaz, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré ao fornecimento do medicamento "Carmen's Medicinals, Full Spectrum, com 6000 mg, sendo 200 mg/ml", a base de canabidiol, para tratamento de crises de dor crônica, ansiedade e insônia, conforme indicado pelo médico do autor. Requisitos do artigo 300 do CPC preenchidos. Cobertura devida. Aplicação em regime domiciliar que não altera a natureza do tratamento médico. Ausência de previsão no rol da ANS que também não obsta a cobertura. Natureza taxativa que admite flexibilizações, conforme

entendimento sedimentado pela Segunda Seção do C. STJ (EREsp nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP, DJe 3/8/22), que fixou parâmetros para a cobertura extrarrol. Inclusão dos §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/98 pela Lei nº 14.454/22. Inteligência da Súmula nº 102, e. TJSP. Preponderância da prescrição médica. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. Demora no tratamento do autor pode acentuar o seu delicado quadro clínico. Tutela reversível. Decisão confirmada. Recurso desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento 2209554-04.2024.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Apelação Cível nº 1005270-31.2023.8.26.0309 - Voto nº 8244 - Pág. 12,

Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2024; Data de Registro: 22/08/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. NEGATIVA ABUSIVA . I. Caso em exame: A autora, beneficiária de plano de saúde, diagnosticada com epilepsia e outras patologias crônicas, teve prescrito medicamento à base de canabidiol para controle das crises epiléticas. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, impondo à ré a obrigação de fornecer o medicamento, com sucumbência recíproca. II . Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a ré é obrigada a fornecer o medicamento à base de canabidiol. III. Razões de decidir: A negativa do plano de saúde é considerada abusiva, uma vez que a Resolução da Anvisa autoriza a importação e comercialização de medicamento à base do canabidiol para fins medicinais. A alegação de que o medicamento não consta no rol da ANS não se sustenta diante da necessidade do tratamento do paciente . IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A negativa de fornecimento de medicamento à base de Canabidiol é abusiva".

(TJ-SP - Apelação Cível: 10052703120238260309 Jundiaí, Relator.: Carlos Castilho Aguiar França, Data de Julgamento: 28/04/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2025)

DIREITO DA SAÚDE. SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL . Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer. Autora portadora de fibromialgia. Fornecimento do medicamento canabidiol prati donaduzzi 20mg/ml. medicamento de uso domiciliar a ser ministrado sob orientação médica . negativa do custeio abusiva. Desprovemento. I. Caso em exame 1 .Apelação cível interposta pela requerida objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido determinando o fornecimento do medicamento Canabidiol Prati Donaduzzi 20mg/ml, mediante apresentação de recomendação médica a ser exigida com periodicidade não inferior a seis meses. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde está obrigado a arcar com o tratamento da beneficiária, portadora de fibromialgia, fornecendo o medicamento Canabidiol Prati Donaduzzi 20mg/ml, de uso domiciliar . III. Razões de decidir 3. Cobertura obrigatória pelos planos de saúde do fornecimento do medicamento à base de canabidiol, que está registrado na Anvisa. Negativa que se configura abusiva . 4. Medicamento de uso domiciliar ministrado sob orientação médica, não cabendo à operadora definir ou questionar a necessidade do tratamento por médico especializado. IV. Dispositivo 5 . Recurso da requerida conhecido e desprovido. _____ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98 Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 STJ; Súmulas 100 e 102 do TJSP; STJ/Tema 990 REsp 1 .712.163/SP; REsp n. 1.886 .929/SP e REsp n. 1.889.704/SP; TJSP/Apelação Cível n . 1022836-28.2023.8.26 .0071; TJSP/Apelação Cível 1002625-66.2022.8.26 .0471

(TJ-SP - Apelação Cível: 10538431220228260576 São José do Rio Preto, Relator.: Regina Aparecida Caro Gonçalves, Data de Julgamento: 23/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 1), Data de Publicação: 23/09/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. UNIMED MACEIÓ. MENOR PORTADOR DE AUTISMO (cid F-84) . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL- TEGRA USALINE 6000MG – 30ML. PARA TRATAMENTO DE GRAVE ENFERMIDADE DE DIFÍCIL CONTROLE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA COMPROVADA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamento Tegra Usaline (CBD) para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) . 2. A questão central consiste em definir a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol prescrito para tratamento de TEA, i) característica de uso domiciliar; (ii) a aplicação do rol da ANS. 3. A relação jurídica configura relação de consumo, aplicando-se o CDC aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ . 4. Resolução RDC nº 17/2015, que trata da importação de medicamento mediante prescrição médica. <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdcn660-de-30-de-marco-de-2022-389908959>. 5. Exclusão de cobertura baseada no uso domiciliar do medicamento caracteriza-se como abusiva, contrariando o objeto do contrato e o art . 51, IV do CDC. 6. O rol da ANS constitui referência básica para cobertura mínima, não limitando os procedimentos que devem ser atendidos pelo plano de saúde. 7 . Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de medicamento à base de canabidiol pelo plano de saúde quando: a) existe prescrição médica específica; b) a negativa se fundamenta no uso domiciliar ou ausência do medicamento no rol da ANS." 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime .

(TJ-AL - Apelação Cível: 07002758120248020050 Porto Calvo, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 14/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. EPILEPSIA . NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO FÁRMACO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTO DERIVADO DE CANNABIS PELA ANVISA. DISTINGUISHING . NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO MESMO EM USO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO STJ PREQUESTIONAMENTO. 1. É abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato, uma vez que a operadora do plano de saúde pode delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não pode restringir os procedimentos e as técnicas a serem utilizadas no tratamento da doença . 2. Embora o medicamento pretendido não conste no rol de procedimento da ANVISA, tal circunstância, por si só, não é suficiente para limitar a cobertura do plano de saúde, isso porque não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento a ser utilizado para cada moléstia, tendo a 3ª Turma do STJ fixado entendimento no sentido de que o plano de saúde tem o dever de custear medicamento à base de canabidiol com importação autorizada pela Anvisa. 3. Ademais, o rol de procedimentos previsto em resoluções normativas da ANS não é taxativo, tese confirmada pela recente Lei nº 14 .454/22, que elenca os procedimentos e medicamentos mínimos que devem ser colocados à disposição dos segurados, competindo, exclusivamente, ao médico, e não ao plano de saúde, a escolha do melhor tratamento a ser submetido ao paciente. 4. Assim, evidenciada a necessidade do medicamento através do relatório médico indicando o uso de medicação à base de Canabidiol, da autorização da Agência de Vigilância Sanitária, em

caráter de excepcionalidade, para a importação de produto derivado da Cannabis e da regulamentação pela própria ANVISA dos critérios e procedimentos para a importação de produto oriundo da referida planta, bem como o direito à saúde, vida, bem-estar e dignidade da autora, a confirmação da sentença é medida que se impõe, caracterizando *distinguishing* a situação que evidencia a segurança sanitária e impõe o fornecimento pela operadora do plano de saúde da parte autora. 5 . A ausência de previsão contratual para cobertura de medicamento de uso domiciliar não afasta a obrigação da operadora do plano de saúde. A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde determina que nos casos de contratação de plano com atendimento ambulatorial, uma das exigências mínimas é o fornecimento de medicamentos para tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral, incluindo até mesmos os considerados adjuvantes. 6 . Quanto ao prequestionamento, sendo devidamente reportados os argumentos alinhavados na peça recursal, não se faz necessário a menção expressa dos artigos indicados pela recorrente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5543134-47.2023 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Algomiro Carvalho Neto, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA . CERCEAMENTO DE DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANS. PROVAS. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA . MEDIDA DESNECESSÁRIA. INUTILIDADE DA PROVIDÊNCIA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMPORTAÇÃO. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEMA REPETITIVO N . 990 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA . ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO DOMICILIAR . CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de produção probatória mediante o pleito de expedição de ofício judicial à Agência Nacional de Saúde (ANS) não representa correlação probatória de imprescindibilidade para o desate da controvérsia inaugurada nos autos, sobretudo porque o acesso aos atos normativos editados pela referida agência reguladora pode ser trazido aos autos diretamente pelas próprias partes ou mediante consulta pública via internet, sendo desnecessária a adoção da providência judicial pleiteada pela recorrente . Precedentes. 2. O apoio do NATJUS, no âmbito deste Tribunal, se restringe a questões relativas ao direito à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, hipótese da qual não se cuida, conforme Portaria GPR 1.170/2018-TJDFT, art . 1º. 3. De acordo com o Enunciado de Súmula 608 do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 4 . O objeto da prestação dos serviços prestados pelas operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial, e que não podem ser negligenciados. 4.1. O Tema Repetitivo n . 990 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável aos casos que versam sobre medicamento cujo princípio ativo seja o Canabidiol e que, apesar de não possuir registro na Anvisa, tem a importação diretamente pela pessoa física, mediante prescrição médica, admitida pela regulação. Precedentes. 4.2 . Mostra-se abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde procedimento ou medicamento necessário para assegurar a preservação da vida do paciente. 5. Tendo sido o tratamento indicado pelo profissional médico que acompanha a paciente, em razão do insucesso na utilização de alternativas terapêuticas, e restando demonstrado que a própria Anvisa já reconheceu a eficiência da substância para o controle da enfermidade que acomete a autora, não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-lo, uma vez que a seguradora pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura. 6 . O fato de o tratamento poder ser realizado em ambiente

domiciliar não representa justificativa para afastar a obrigatoriedade do custeio dele pela seguradora. Isso porque o contrato de plano de saúde pode conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, mas há abusividade no preceito que exclui do custeio o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento da segurada, ainda que administrado em ambiente domiciliar. 7. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada . Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.

(TJ-DF 07061511820238070016 1884340, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 26/06/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIAL – PACIENTE COM AUTISMO E EPILEPSIA SEVERA, SEM RESPOSTA A MEDICAMENTO/PROCEDIMENTOS ANTERIORES – FÁRMACO A BASE DE CANABIDIOL – PROMEDIOL 50MG/ML - ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS E DE USO DOMICILIAR – NEGATIVA INDEVIDA – RESOLUÇÃO Nº 2324/2022 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA RECOMENDANDO O USO DO MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL PARA O TRATAMENTO DE EPILEPSIA GRAVE – RECOMENDAÇÃO DE CONSELHO FEDERAL APLICÁVEL A LEADING CASE - DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Quando do julgamento dos recursos EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.70 foi fixada a seguinte tese: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 . É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Adentrando a análise das diretrizes fixadas pelo STJ e pela Lei 14.454/2022, na hipótese em análise, o medicamento cannabis sativa promediol 50mg/ml não se encontra previsto no rol da ANS, entretanto, em pesquisa ao banco de dados do STJ em caso análogos, constata-se que há Resolução do Conselho Federal de Medicina (nº 2.113/2014), posteriormente substituída pela Resolução nº 2.324/2022, aprovando o uso de tal substância para o tratamento exclusivo de epilepsias em criança e adolescente refratárias aos tratamentos convencionais, em nítido encaixe ao caso sub judice.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10388024120238110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

Por fim, quanto à multa cominatória fixada na decisão agravada, observa-se que seu valor visa assegurar o cumprimento da obrigação de fazer e garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sendo compatível com a gravidade da situação e a urgência do tratamento necessário ao menor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos da fundamentação acima, determinando que a operadora de plano de saúde HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. forneça ao autor o medicamento à base de canabidiol (CBD 200mg/ml – Prati Donaduzzi), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária fixada na decisão agravada.

É como VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora